

Aneurisma de aorta abdominal - ruptura

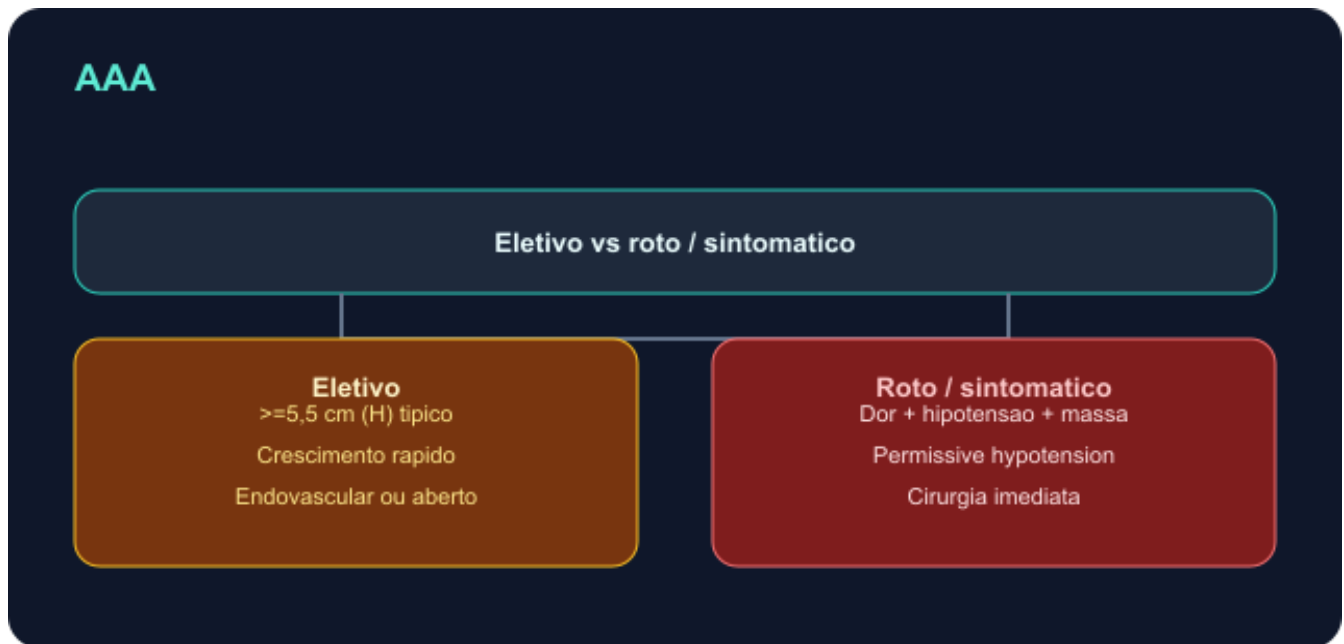
AAA sintomático ou roto é emergência vascular. Eletivo repara-se tipicamente a partir de ~5,5 cm (homem) ou crescimento rápido/sintomas — confirme o critério da banca.

Tríade da ruptura

Dica - Tríade da ruptura

Dor abdominal/lombar + hipotensão + massa pulsátil. Nem sempre completa — em idoso tabagista com síncope e dor lombar, pense AAA.

Dois mundos: vigilância/reparo programado versus sala de emergência e reanimação permissiva.



Conduta

- Roto: acesso venoso grosso, tipagem, não buscar normotensão agressiva (hipotensão permissiva)
- TC só se estável o suficiente e diagnóstico incerto; instável vai direto à cirurgia se alta probabilidade
- EVAR vs aberto conforme anatomia, estabilidade e expertise
- Rastreio: homens idosos tabagistas — USG (protocolos de prevenção)

Limiares úteis

Situação | Conduta típica

<4–4,5 cm | Vigilância com imagem

≥5,5 cm (&B) | Indicação eletiva frequente

Sintomático | Reparar (urgência)

Roto | Emergência operatória

Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

Não faça colonoscopia/endoscopia ou reposição volêmica agressiva buscando PA 'normal' no AAA roto — pode romper tampão. Evite palpação brutal da massa.